

RECURSO CÍVEL Nº 5072274-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA RITA ARAUJO SANTANA (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: ARTHUR ARAUJO SANTANA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. DIFÍCIL CONTROLE DE GLICEMIA. EQUIPAMENTO NÃO CONSTANTE DAS LISTAS DE FORNECIMENTO DO SUS. EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO DE ÍNDICES GLICÊMICOS POR OUTRO MEIO FORNECIDO PELO SUS, SMCG. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MONITOR FREESTYLE® LIBRE E SENSOR DE FREESTYLE LIBRE®. SENTENÇA FUNDAMENTADA COM PARECER DO NAT. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995), observando o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado dê-se baixa e devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5072274-62.2024.4.02.5101

510015340698 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5072274-62.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA RITA ARAUJO SANTANA (PAIS) (AUTOR)

RECORRENTE: ARTHUR ARAUJO SANTANA DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de improcedência do pedido de fornecimento do aparelho Monitor FreeStyle® Libre e Sensores FreeStyle Libre®, utilizado para o monitoramento de índices glicêmicos.

Segue a sentença:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Trata-se de ação proposta por ARTHUR ARAUJO SANTANA DA SILVA, representado por MARIA RITA ARAUJO SANTANA, em face de UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, na qual pretende, inclusive em sede de tutela de urgência:

(...)

b) concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se que os réus, solidariamente, propiciem as condições necessárias para o tratamento do autor, obrigando-os a fornecerem, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição do médico responsável, os insumos Monitor FreeStyle® Libre e Sensores de FreeStyle Libre®, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de, não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas

verbas no montante necessário para custear os produtos na rede privada, ou, nos termos do art. 77, IV, c/c art. 139, IV, e art. 297 do CPC, sejam aplicadas medidas de apoio para efetivação da tutelada tutela provisória de urgência.

(...)

d) que seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO, com a confirmação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para fins de CONDENAR os réus a fornecerem à parte autora os insumos Monitor FreeStyle® Libre e Sensores FreeStyle Libre®, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de, não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas verbas no montante necessário para custear os produtos na rede privada, ou, nos termos do art. 77, IV, c/c art. 139, IV, e art. 297 do CPC, sejam aplicadas medidas de apoio para efetivação da tutelada tutela provisória de urgência.

(...)

Segundo o relatado na petição inicial, de acordo com laudo médico, emitido pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, o autor, criança de 09 anos de idade, possui o diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID: E10), desde 2020, apresentando labilidade glicêmica e cetoacidose. Além disso, apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID: F84) e realiza o tratamento para sua condição utilizando fitas de medição capilares de glicemia. No entanto, devido ao Transtorno do Espectro Autista, apresenta dificuldade em identificar os quadros de hipoglicemia. Relata ainda que, além disso, costuma apresentar quadros de hipoglicemias, sem alarme, nos intervalos entre as medições capilares, conforme esclarece o formulário médico acostado aos autos.

Apresentado parecer técnico pelo Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT-Jus no evento 31.

Cabe destacar que as três esferas da Federação têm legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tenham por base a existência de obrigações relativas ao SUS, qualquer que seja o pedido em si. Nesse sentido, os Tribunais Superiores vêm admitindo a responsabilidade solidária dos entes federativos, quando se trata do dever de prestação de saúde, tendo o e. STF, recentemente, pacificado o tema, fixando a seguinte tese de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793):

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, **são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde**, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Ata nº 18, de 23/05/2019. DJE nº 119, divulgado em 03/06/2019)

Tal entendimento encontra-se, inclusive, sedimentado no Enunciado nº 43 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais desta Seção Judiciária do Rio de Janeiro, in verbis:.

Enunciado 43: “A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS”.

Ademais, a descentralização administrativa dos serviços e recursos financeiros tem por fim tão somente melhorar a qualidade e o acesso à saúde e não pode se prestar para afastar a responsabilidade de quaisquer dos entes. Pelo contrário, reforça a responsabilidade solidária, pois indica o trabalho conjunto para perseguir o fim constitucional.

Nessa mesma linha, o enunciado nº 60, aprovado na II Jornada de Direito de Saúde promovida pelo CNJ:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para o indivíduo.

No entanto, o seu acesso deve se dar em igualdade de condições entre aqueles que necessitem se valer da prestação desse tipo de serviço.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS o fornecimento de medicamentos, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação de que necessitem.

Em observância ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos da jurisprudência dominante, que a garantia aos medicamentos deve se dar mesmo que estes não constem na listagem oficial, de vez que o não preenchimento de mera formalidade - no caso, a inclusão de medicamento em lista prévia - não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação, se comprovada a respectiva necessidade e receita, aquela, por médico para tanto capacitado (RESP - RECURSO ESPECIAL - 684646/RS).

(...)

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para atingir o bom controle glicêmico é necessário que os pacientes realizem avaliações periódicas dos seus níveis glicêmicos. O automonitoramento do controle glicêmico é uma parte fundamental do tratamento e este pode ser realizado através da medida da glicose no sangue capilar (teste padronizado pelo SUS) **ou pela monitorização contínua da glicose (MGC)**. Os resultados dos testes de glicemia devem ser revisados periodicamente com a equipe multidisciplinar e, os pacientes orientados sobre os objetivos do tratamento e as providências a serem tomadas quando os níveis de controle metabólico forem constantemente insatisfatórios. O monitoramento da Glicemia Capilar (GC) continua recomendado para a tomada de decisões no manejo de hiper ou hipoglicemia, mesmo em pacientes que utilizam monitoramento contínuo.

(...)

Cabe ressaltar que o uso do SMCG **não exclui a aferição da glicemia capilar (teste convencional e disponibilizado pelo SUS)** em determinadas situações como: 1) durante períodos de rápida alteração nos níveis da glicose (a glicose do fluido intersticial pode não refletir com precisão o nível da glicose no sangue); 2) para confirmar uma hipoglicemia ou uma iminente hipoglicemia registrada pelo sensor; 3) quando os sintomas não corresponderem as leituras do SMCG.

(...)

Quanto à disponibilização de FreeStyle Libre® e sensores no âmbito do SUS, **não estão padronizados em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS**, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

(...)

Destaca-se que o aparelho FreeStyle Libre® possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) . (GN)

Por fim, o parecer técnico do NAT-Jus asseverou que:

Diante do exposto, informa-se que o aparelho FreeStyle Libre® e sensores apesar de estarem indicados para o manejo do quadro clínico do autor, **não são imprescindíveis**. Isto decorre do fato, de **não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS**. (GN)

Repisa-se que a primeira seção do STJ, em recente julgamento do REsp 1.657.156/RJ (DJe de 04/05/2018), vinculado ao tema repetitivo 106, firmou a tese a seguir redigida:

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2. incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3. existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1657156, DJe 21/09/2018).

Vejamos recente julgado da 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região sobre caso similar:

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença, verbis (processo 5021133-04.2024.4.02.5101/RJ, evento 33, SENT1):

(...)

VOTO

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva e à solidariedade dos entes públicos federativos, verbis:

“**Processo** REsp 1203244 / SC **RECURSO ESPECIAL** 2010/0137528-8

Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

Data do Julgamento 09/04/2014

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. **RECURSO** REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTOS**. AÇÃO MOVIDA CONTRA O **ESTADO**. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de **medicamentos** ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE

607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA Seção do Superior Tribunal de Justiça: "A Seção, por unanimidade, negou provimento ao **recurso** especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram, oralmente, os Drs. SÉRGIO LAGUNA PEREIRA, pelo recorrente, e DANIELLE ALEIXO REIS DO VALLE SOUZA, pela União.

Notas

Julgado conforme procedimento previsto para os **Recursos Repetitivos** no âmbito do STJ. Veja os **EDcl no REsp 1203244-SC** que foram acolhidos."

Assim, os cidadãos podem postular a concessão de medicamentos, insumos e, por analogia, procedimentos médicos de todos os órgãos federados, competindo à parte autora da ação eleger contra quem pretende demandar, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados.

Foi realizada, corretamente, a intimação do Núcleo de Assistência Técnica, NAT, para emissão de parecer, nos termos do que dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

O NAT juntou parecer (6.1):

(...)

Nos termos do parecer: "Diante o exposto, informa-se que o aparelho FreeStyle Libre e sensor apesar de estarem indicados para o manejo do quadro clínico da Autora, diabetes mellitus tipo 1, apresentando labilidade glicêmica frequente (Evento 1, ANEXO2, Página 8 a 12) não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS."

De tal sorte, o parecer foi categórico ao afirmar que que embora os medicamentos/insumos estejam indicados para a patologia da parte autora, os mesmos não são imprescindíveis.

O NAT é composto por uma equipe de especialistas em saúde pública e para a emissão do parecer foram utilizados e analisados os documentos juntados pela parte autora.

Assim está ausente a probabilidade do direito pleiteado.

Tal decisão já foi objeto de orientação por essa Turma Recursal:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NAO INCORPORADOS. FALTA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. O CONITEC deliberou por nao recomendar a incorporacao ao SUS do sistema de injecao continua de insulina, de modo que, somente seria possivel a condenacao dos entes publicos, a fornecer tal insumo, caso comprovada a ineficacia do esquema padronizado pelo SUS e a imprescindibilidade do metodo pretendido, o que inoocorre.
Sessão de 17/07/2023. Relator LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA. Processo 5006680- 15.2022.4.02.5120.

O Enunciado 12 do CNJ determina a necessidade de demonstração da ineficácia do tratamento do SUS. Nos termos do Enunciado: "A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)".

Por todo o exposto, voto por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, com a respectiva manutenção da sentença.** Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se.

processo 5021133-04.2024.4.02.5101/RJ, evento 68, RELVOTO1

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** os pedidos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º, da Lei nº 10.259/2001.

Intimem-se as partes, dando-lhes ciência da sentença. Decorrido in albis o prazo para a parte autora interpor recurso, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, já que não há interesse da parte ré em recorrer, uma vez que a sentença é de improcedência do pedido da parte autora.

Em havendo interposição de recurso, dê-se vista à parte contrária e, posteriormente, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

O prazo para recurso será de 10 (dez) dias úteis.

Tudo cumprido, dê-se baixa e arquivem-se, observadas as cautelas de praxe.

Intimem-se, inclusive o Ministério Público Federal - MPF.

Recurso inominado no evento 77. Alega a parte autora que padece de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10) e Transtorno do Espectro Autista, necessitando dos aparelhos Monitor FreeStyle® Libre e Sensor de FreeStyle Libre® para o seu tratamento com o monitoramento dos índices glicêmicos.

VOTO

Em seu parecer, o NAT informa a disponibilização pelo SUS do Sistema de Monitoramento Contínuo da Glicose (SMCG), que apresenta a eficiência necessária para os cuidados da parte autora. O equipamento requerido não é fornecido pelo SUS.

Considerando que a análise procedida pelo Juízo de origem, devidamente fundamentada, está em conformidade com os elementos probatórios constantes dos autos e o direito aplicável; e que os argumentos trazidos pelo recorrente não são aptos a afastar a decisão de primeiro grau, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios termos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Sobre a forma de decidir adotada, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ADOTADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.1.

Decisão fundamentada de Turma Recursal, sucinta e contrária aos interesses da parte que, com base na Lei 9.099/95, adota os fundamentos da sentença por seus próprios fundamentos, não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (STF, AG.REG.NO AGRADO DE INSTRUMENTO: AI 701043 RJ, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 04/08/2009, Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação: DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-13 PP-02589 - v.g.)”

Ante todo o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Condene o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995), observando o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado dê-se baixa e devolvam-se os autos ao juízo de origem.

5072274-62.2024.4.02.5101

510015340697 .V6